

مرض بيروني حالة تتشكّل فيها بقعة من النسيج الندبي (اللوحة) في جدار القضيّب، مما يُسبّب تقوّسه أو تضيقه أو انبعاجه أو قصّره، وأحياناً ألماً أثناء الانتصاب. قد يُصعّب ذلك الجماع. الحالة شائعة، ليست سرطانية، وتوجد علاجات فعّالة — يتوقف الأنسب منها على مرحلة المرض.

عن هذه الحالة

يمرّ مرض بيروني عادةً بمرحلتين:

- **المرحلة النشطة (الحادة)** — التقوّس في تغيّر مستمر وقد يصحبه ألم، وتمتد غالباً 6-18 شهراً.
- **المرحلة المستقرة** — يثبت التقوّس واللوحة وعادةً يتراجع الألم.

تعتمد خيارات العلاج على المرحلة التي أنت فيها، لذا سيشارك فريقك الطبي عن تطوّر الحالة مع الوقت.

الأسباب

يُعتقد أن المرض يبدأ بانحناء بسيط أو إصابة طفيفة أثناء الجماع تلتزم بندبة غير طبيعية بدلاً من نسيج سليم. يزداد شيوعاً مع التقدم في السن والسكري وبعد جراحة البروستاتا، وفي الرجال المصابين أيضاً بـ **تقلّص دوبيوتران** (حالة مشابهة تُصيب اليد).

تعلم المصطلحات

مرض بيروني

نسيج ندبي في القضيّب يُسبّب تقوّساً أو تشوّهاً.

اللوحة

بقعة النسيج الندبي المسؤولة عن الانحناء.

النشط مقابل المستقر

هل التقوّس لا يزال يتغيّر أم ثبت؟

العلاج بالشّد

جهاز يمدّ القضيّب بلطف لتحسين الانحناء والطول.

كولاجينيز (Xiaflex)

دواء يُحقن في اللوحة لتفتيتها.

التخييط / الترقيع

طريقتان جراحيتان لتقويم القضيّب.

هل يجب التسرع في الجراحة؟ عادةً لا. في المرحلة النشطة، يتغير التقوس باستمرار، لذا يتركز الاهتمام على الراحة والخيارات غير الجراحية. تُطرح جراحة التقويم بعد أن تصبح الحالة مستقرة (ثبات التقوس وزوال الألم). كثير من الرجال يتحسنون دون تدخل جراحي.

كيف تُشخص

معلومات مفيدة

- لا تحاول تقويم القضيب بالقوة — قد يُفاقم الإصابة.
- التقوس الذي لا يمنع الجماع قد يُراقب فقط.
- يؤثر المرض على المزاج والعلاقات — الدعم النفسي مفيد.

- استعراض تاريخ التقوس والألم وتطورهما
- فحص لتحسس اللويحة؛ وأحياناً تصوير الانتصاب أو تقييم في العيادة
- في بعض الحالات، موجات فوق صوتية لرسم اللويحة وتدفق الدم

كيف تُعالج (حسب المرحلة)

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- تقوس يمنع الجماع أو تفاقم الانحناء
- ألم شديد مع الانتصاب
- ضعف انتصاب جديد مصحوب بالتقوس

ثلاثة أمور تدكرها

1. مرض بيروني نسيج ندبي يُقوس القضيب — شائع وليس سرطاناً وقابل للعلاج.
2. يعتمد العلاج على المرحلة: راحة وخيارات غير جراحية في المرحلة النشطة؛ وإجراءات التقويم بعد الاستقرار.
3. كثيرون يتحسنون دون جراحة. راجع فريقك عند تقوس يمنع الجماع، أو ألم مستمر، أو ضعف انتصاب جديد.

1 المرحلة النشطة — الطمأنينة والتحكم في الألم وكثيراً ما يُستخدم العلاج بالشد؛ والهدف الحد من التفاقم.

2 حقن اللويحة — أدوية ككولاجينيز (Xiaflex) تُحقن في اللويحة لتقليل التقوس.

3 الجراحة (المرحلة المستقرة) — التخطيط (خياطة الجانب الأطول؛ أبسط وقد يُقصر القضيب) أو شق اللويحة وترقيعها (للحفاظ على الطول، للتقوسات الشديدة).

4 دعامة القضيب — عند وجود ضعف الانتصاب (ED) أيضاً. لكل خيار نشرة مستقلة.